

KỸ THUẬT HÚT DỊCH DẠ DÀY



Mục tiêu:

1. Nêu được mục đích, chỉ định và chống chỉ định của việc hút dịch dạ dày.
2. Mô tả và thực hiện được kỹ thuật hút dịch dạ dày.
3. Kể được những điều cần lưu ý trong việc hút dịch dạ dày.

1. Định nghĩa.

Hút dịch dạ dày là thủ thuật đưa ống thông bằng cao su qua đường mũi hoặc miệng vào dạ dày để hút dịch trong dạ dày với mục đích để trị liệu hay chẩn đoán.

2. Mục đích.

2.1. Chẩn đoán bệnh.

- Xét nghiệm tìm vi khuẩn.
- Xác định thành phần, tính chất, số lượng dịch dạ dày để góp phần chẩn đoán một số bệnh.
- Lấy dịch vị để chẩn đoán một số bệnh về dạ dày.
- Tìm vi trùng lao có trong dịch dạ dày.
- Chuẩn bị người bệnh chụp X-Quang hệ tiêu hóa.

2.2. Điều trị.

- Giảm áp lực trong dạ dày do hơi hoặc dịch...
- Lấy hơi hoặc chất ứ đọng trong dạ dày trước khi mổ.
- Ngừa và trị chướng bụng sau khi phẫu thuật.
- Lấy chất dịch ứ đọng trong dạ dày, ruột: trường hợp người bệnh hẹp môn vị, tắc ruột, bán tắc ruột.

3. Các phương pháp hút dịch dạ dày

3.1. Hút ngắt quãng – hút đơn giản: đặt ống vào dạ dày, dùng bơm tiêm lấp vào đầu ngoài của ống, hút dịch ra hoặc để dịch tự chảy vào túi chứa theo trọng lực.

3.2. Hút liên tục: với lực hút của máy từ 9 – 12mmHg, áp lực này không làm tổn thương niêm mạc dạ dày gây xuất huyết.

* Mục đích:

- Tìm vi khuẩn.
- Xét nghiệm thành phần, tính chất, số lượng dịch vị.
- Xét nghiệm áp lực trong dạ dày.
- Lấy dịch vị khi đói để xem có dịch ứ đọng, hoặc hiện tượng tăng tiết dịch.
- Tìm tế bào giúp chẩn đoán bệnh ở dạ dày.
- Lấy dịch vị sau khi tiêm histamin kiểm tra sự bài tiết HCL và pepsin.

4. Chỉ định.

- Nghi ngờ (theo dõi lao phổi ở trẻ em), vì lao phổi trẻ em, trẻ em không biết khạc đàm mà thường nuốt đàm.
- Các bệnh viêm dạ dày, loét dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày, hẹp môn vị, chướng bụng, liệt ruột, tắc ruột.
- Giải phẫu đường tiêu hóa: trước, trong và sau khi phẫu thuật ở đường tiêu hóa (đặt biệt là phẫu thuật ở dạ dày).

5. Chống chỉ định.

- Bệnh ở thực quản: hẹp, co thắt, phình tĩnh mạch thực quản → ngừa tai biến xuất huyết.
- Bỏng thực quản do hóa chất mạnh: acid, baze...
- Trường hợp nghi thủng dạ dày.

6. Chuẩn bị người bệnh.

- Giải thích cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh biết để họ yên tâm và hợp tác.
- Tư thế người bệnh thích hợp. (Ngồi hoặc nằm đầu cao $30^0 - 45^0$, giúp ống sonde đi qua đoạn mũi-hầu dễ dàng).

- Nếu người bệnh nặng cần có người phụ giúp.

7. Dọn dẹp dụng cụ.

- Rửa sạch, lau khô.
- Chuẩn bị dụng cụ gửi đi tiệt khuẩn.
- Trả những dụng cụ khác về chỗ cũ.

8. Ghi hồ sơ.

- Ngày giờ thực hiện.
- Số lượng, tính chất, màu sắc dịch được hút ra.
- Số mẫu nghiệm gửi (nếu có).
- Tình trạng người bệnh.
- Tên điều dưỡng thực hiện.

9. Những điều cần lưu ý khi hút dịch dạ dày.

- Trường hợp để xác định số lượng dịch dạ dày: hút cho đến lúc dịch không còn chảy ra nữa. Sau đó ghi nhận màu sắc, tính chất, số lượng của dịch dạ dày.
- Nếu tìm trực khuẩn lao: lấy 5ml cho vào ống nghiệm và gửi phòng xét nghiệm.
- Kích cỡ ống hút dịch dạ dày (tube levine) phải phù hợp với người bệnh:
 - + Người lớn: 14 – 16 Fr.
 - + Trẻ nhỏ: 8 – 10 Fr.
- Khi đặt ống hút phải đặt nhẹ nhàng → tránh gây tổn thương và đau đớn cho người bệnh. Nếu đặt ống qua đường mũi, cần nhẹ nhàng → tránh xây sát niêm mạc mũi.
- Nếu người bệnh tỉnh bảo người bệnh há miệng để xem ống có bị cộn vòng trong miệng không? Nếu người bệnh ho, sặc, tím tái phải rút ống ra ngay. Vì ống đi lạc qua đường hô hấp.
- Phải luôn quan sát người bệnh trong lúc đặt ống thông, nếu thấy người bệnh ho, sặc sụa tiết nhiều đàm nhớt, khó thở, tím tái → rút ống ra, đặt lại.
- Khi cố định ống hút, phải cố định đúng cách để người bệnh xoay trở dễ dàng, tránh ống thông bị tuột ra ngoài.
- Khi hút dịch dạ dày: không được di động ống thông tránh tổn thương niêm mạc dạ dày.

- Chọn lực hút thích hợp, nếu có chỉ định hút liên tục thì hút nhẹ nhàng và từ từ với áp lực thấp.
- Theo dõi tình trạng chung của người bệnh số lượng, màu sắc, tính chất dịch hút ra.
- Chăm sóc mũi, miệng người bệnh trong suốt thời gian đặt ống để hút (nếu hút liên tục).
- Dặn người bệnh hoặc người nhà người bệnh không được tự ý rút ống thông ra hoặc tự điều chỉnh áp lực hút.
- Thường xuyên bơm rửa ống thông bằng dung dịch NaCl 0,9% hoặc nước chín → phòng ống thông bị tắc.
- Thường xuyên thay đổi ống thông, khi thay ống thì đổi luôn cả bên lỗ mũi để đặt ống thông.
- Thường xuyên kiểm tra ống thông có còn đúng vị trí không.

BẢNG KIỂM DỤNG CỤ HÚT DỊCH DẠ DÀY

STT	NỘI DUNG	Có	Không
1	Rửa tay.		
2	Trải khăn sạch lên mâm sạch.		
3	Soạn các dụng cụ trong mâm: - Tube Levine. - Ly nước chín. - Que gòn, que đè lưỡi. - Gạc. - Ống tiêm 20ml. - 6 – 10 ống nghiệm.		
4	Soạn các dụng cụ khác: - Bồn hạt đậu sạch. - Găng tay sạch. - Khăn long. - Tấm nylon. - Băng keo. - Ống nghe. - Túi đựng rác y tế. - Chất trơn (nếu cần). - Dung dịch sát khuẩn tay nhanh. - Phiếu xét nghiệm.		

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT HÚT DỊCH DẠ DÀY

STT	NỘI DUNG	Có	Không
1	Chào hỏi BN, tên giới tên ĐD, Báo và giải thích cho người bệnh, xác định đúng họ, tên, SN, kiểm SNV.		
2	Cho người bệnh ngồi hoặc nằm đầu cao		
3	Choàng tấm nylon và khăn qua cổ người bệnh		
4	Vệ sinh 2 lỗ mũi (nếu đặt ở mũi)		
5	Đặt bông hạt đậu cạnh má		
6	Rửa tay nhanh, mang găng sạch		
7	Đo ống từ cánh mũi (miệng) đến trái tai, từ trái tai đến mũi ực		
8	Làm dấu bằng băng keo nhỏ		
9	Dùng gạc cầm tube Levine nhúng vào ly nước làm trơn ống, vẩy cho ráo nước đầu ống (hoặc dùng gạc có chất trơn bôi trơn đầu ống)		
10	Đưa ống qua mũi (miệng) đến hầu bảo bệnh nhân nuốt		
11	Dùng que đè lưỡi kiểm tra ống qua khỏi hầu		
12	Đưa tube Levine vào tiếp tục theo nhịp nuốt của người bệnh		
13	tới mức làm dấu		
	Thử ống: đi từng bước một: - Nhúng đầu ống sonde vào ly nước xem có sủi bọt không (nếu có sủi bọt theo nhịp thở là đưa nhầm vào đường khí quản). - Rút dịch trong dạ dày thử trên giấy quỳ nếu là acid thì ống đã vào đúng dạ dày (nếu không) - Bơm hơi vào dạ dày (# 20 - 30ml), đồng thời đặt ống nghe vùng thượng vị để kiểm tra		

14	Cố định ống ở mũi và má.		
15	Hút 5 – 10 ml dịch cho vào ống nghiệm		
16	(Lưu ý phải kiểm kỹ họ tên, SN, SNV ống nghiệm phù hợp họ tên, sn, snv của NB)		
17	Cầm gấp ống lại, rút ống dần ra		
18	Cho người bệnh súc miệng		
19	Lau sạch miệng, mũi người bệnh bằng khăn		
20	Tháo găng, giúp người bệnh tiện nghi		
	Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ, gửi mẫu đi xét nghiệm		

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đoàn Thị Anh Lê (2014). Giáo trình điều dưỡng cơ sở. Trường Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Y học.
2. Cao Văn Thịnh (2014). Giáo trình Điều dưỡng cơ bản tập 2. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nhà xuất bản Y học.